

Catálogo de User Stories

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Documento elaborado por la comisión de Análisis y Management – Enunciado 2

1. Propósito y alcance del documento

Este documento redacta las 62 User Stories derivadas del listado de requerimientos, con sus criterios de aceptación, prioridad, estimación y sprint asignado. Es el insumo directo para las reuniones de refinement, para la asignación de tareas al equipo implementador y para la verificación de las demos.

Las User Stories están agrupadas por sprint, siguiendo la distribución propuesta en el bosquejo de sprints. La asignación es tentativa: la priorización definitiva se acuerda con el ayudante en su rol de cliente durante el Sprint 0, y se re-prioriza al cierre de cada sprint.

Pendiente: las pautas del proyecto exigen que la descripción de las User Stories vaya acompañada de wireframes que representen la disposición de botones, campos y títulos, y recomiendan un sitemap. La sección 8 lista las pantallas que hay que dibujar; los wireframes se adjuntan como anexo a este documento antes de la revisión del Sprint 0.

2. Formato y convenciones

Cada User Story se redacta en el formato estándar **Como «rol», quiero «acción», para «beneficio»**, seguido de sus criterios de aceptación verificables y de la trazabilidad al requerimiento que le da origen.

- **Prioridad:** escala MoSCoW heredada del listado de requerimientos (Must, Should, Could).
- **Puntos:** estimación relativa en puntos de historia, con la equivalencia inicial de 1 punto ≈ 4 horas de trabajo del equipo implementador. La escala se recalibra con la velocidad real del Sprint 1.
- **Sprint:** etapa en la que está planificada su implementación. Las User Stories de la sección 7 no están comprometidas en ningún sprint.
- **Trazabilidad:** requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que la User Story satisface.

Las User Stories cuyo rol es *sistema* o *responsable del sistema* describen comportamiento automático o transversal sin actor humano directo. Se redactan como historias porque tienen criterios de aceptación verificables en la demo, aunque no correspondan a una pantalla propia.

3. Definición de terminado

Una User Story se considera terminada cuando cumple **todas** las condiciones siguientes. Este criterio es común a todas las historias del documento y no se repite en cada una.

#	Condición
1	Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican como cumplidos.
2	El código está integrado en la rama principal del repositorio compartido con la comisión de Análisis y Management.
3	La funcionalidad fue probada por alguien distinto de quien la desarrolló.
4	Los casos de prueba y los bugs detectados están documentados según el mecanismo acordado entre ambas comisiones.
5	No quedan bugs de severidad alta abiertos sobre la historia.
6	El control de acceso por rol fue verificado para la funcionalidad incorporada.
7	La historia es demostrable de punta a punta en la reunión de demo.

4. Índice de User Stories

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Sprint
US-01	Registro de paciente	Usuarios y acceso	Must	3	1
US-02	Inicio de sesión con interfaz según rol	Usuarios y acceso	Must	3	1
US-03	Alta y baja de usuarios internos	Usuarios y acceso	Must	3	1
US-04	Restricción de acceso por rol	Usuarios y acceso	Must	2	1
US-05	Actualización de datos personales	Usuarios y acceso	Should	1	1
US-06	Carga de disponibilidad mensual	Agenda médica	Must	4	1
US-07	Validación de la regla de dos jornadas semanales	Agenda médica	Must	2	1
US-08	Generación automática de turnos	Agenda médica	Must	5	1
US-09	Prevención de turnos superpuestos	Agenda médica	Must	3	1
US-10	Apertura automática de la agenda	Agenda médica	Must	2	1
US-11	Vista de agenda del profesional	Agenda médica	Must	4	1
US-12	Búsqueda de turnos disponibles	Reserva de turnos	Must	3	2
US-13	Reserva de turno	Reserva de turnos	Must	3	2
US-14	Confirmación de reserva por email	Reserva de turnos	Must	2	2
US-15	Recordatorio automático de turno	Reserva de turnos	Must	2	2
US-16	Cancelación de turno por el paciente	Reserva de turnos	Must	2	2
US-17	Gestión de turnos desde mostrador	Reserva de turnos	Should	3	2
US-18	Registro del estado del turno	Reserva de turnos	Must	2	2
US-19	Prevención de turnos duplicados	Reserva de turnos	Should	1	2
US-20	Control de concurrencia en la reserva	Reserva de turnos	Must	2	2
US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	Notificaciones	Must	3	2
US-22	Aviso por modificación de agenda	Notificaciones	Must	1	2
US-23	Alerta de stock bajo a enfermería	Notificaciones	Must	1	2
US-24	Catálogo de vacunas	Gestión de vacunas	Must	2	2
US-25	Registro de stock por lote	Gestión de vacunas	Must	2	2
US-26	Descuento automático de stock	Gestión de vacunas	Must	1	2
US-27	Umbral mínimo por vacuna	Gestión de vacunas	Must	2	2
US-28	Turno de vacunación con verificación de stock	Gestión de vacunas	Must	2	2
US-29	Registro de aplicación de dosis	Gestión de vacunas	Must	1	2
US-30	Bloqueo de franjas publicadas	Agenda médica	Should	3	2
US-31	Recuperación de contraseña	Usuarios y acceso	Should	1	2
US-32	Registro de cobertura médica	Pagos y coberturas	Must	2	3
US-33	Configuración de aranceles	Pagos y coberturas	Must	2	3
US-34	Cálculo del importe según cobertura	Pagos y coberturas	Must	3	3
US-35	Registro del pago de la consulta	Pagos y coberturas	Must	2	3
US-36	Comprobante de pago	Pagos y coberturas	Must	1	3
US-37	Factura descargable en PDF	Pagos y coberturas	Must	2	3
US-38	Historial de pagos del paciente	Pagos y coberturas	Should	1	3

ID	Título	Módulo	Prio.	Pts	Sprint
US-39	Carga de diagnóstico y tratamiento	Historial clínico	Must	3	3
US-40	Consulta de la ficha del paciente	Historial clínico	Must	2	3
US-41	Historial clínico del paciente	Historial clínico	Must	2	3
US-42	Trazabilidad de las entradas clínicas	Historial clínico	Should	2	3
US-43	Antecedentes, alergias y medicación habitual	Historial clínico	Should	1	3
US-44	Auditoría de accesos al historial	Historial clínico	Should	1	3
US-45	Reporte de turnos por especialidad	Reportes	Must	2	3
US-46	Reporte de stock de vacunas	Reportes	Must	2	3
US-47	Reporte de pagos realizados	Reportes	Must	1	3
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	Reportes	Must	1	3
US-49	Filtros comunes de reportes	Reportes	Should	1	3
US-50	Exportación de reportes	Reportes	Should	1	3
US-51	Acceso desde la aplicación móvil	Aplicación móvil	Must	2	3
US-52	Gestión de turnos desde el móvil	Aplicación móvil	Must	3	3
US-53	Historial clínico desde el móvil	Aplicación móvil	Must	2	3
US-54	Recordatorios en el móvil	Aplicación móvil	Must	1	3
US-55	Pagos y comprobantes desde el móvil	Aplicación móvil	Should	2	3
US-56	Vencimiento y baja de lotes	Gestión de vacunas	Should	2	3
US-57	Carnet de vacunación del paciente	Gestión de vacunas	Should	1	3
US-58	Registro de notificaciones enviadas	Notificaciones	Should	1	3
US-59	Lista de espera de turnos	Reserva de turnos	Could	3	—
US-60	Calendario de feriados	Agenda médica	Could	2	—
US-61	Anulación de pagos	Pagos y coberturas	Could	2	—
US-62	Adjuntar estudios a la ficha	Historial clínico	Could	3	—

5. Sprint 1 – Cimientos y agenda

Demo 08/10, entrega 11/10. Identidad, control de acceso y todo el ciclo de la agenda médica: desde la carga de disponibilidad del profesional hasta la publicación de los turnos a los pacientes.

11 User Stories – 32 puntos de historia

Usuarios y acceso

US-01 Registro de paciente	Must 3 pts Sprint 1
Como visitante, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales y de contacto, para poder acceder al sistema y reservar turnos. Criterios de aceptación – El formulario solicita nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, email y contraseña, y se registra con un mail y contraseña – El sistema rechaza el registro si el documento o el email ya están asociados a otra cuenta. – Al completarse el registro, el usuario queda con rol Paciente y puede iniciar sesión inmediatamente. – El manejo de contraseñas se maneja con servicio de terceros Trazabilidad: RF-USR-01, RNF-01	
US-02 Inicio de sesión con interfaz según rol	Must 3 pts Sprint 1
Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales y llegar a la pantalla propia de mi rol, para acceder directamente a las funciones que me corresponden sin navegar por opciones ajenas. Criterios de aceptación – El sistema valida las credenciales y redirige según el rol: paciente, médico, enfermera, administrativo o administrador. – Ante credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe. – El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla. – Cada rol ve un menú distinto sobre una misma identidad visual. Trazabilidad: RF-USR-02, RNF-06	
US-03 Alta y baja de usuarios internos	Must 3 pts Sprint 1
Como administrador, quiero dar de alta, modificar y desactivar las cuentas de médicos, enfermeras y administrativos, para controlar quién accede al sistema sin depender del área técnica. Criterios de aceptación – El administrador puede crear un usuario indicando datos personales, rol y, en el caso de los médicos, su especialidad. – Las especialidades disponibles son clínica, pediatría y traumatología. – Posteriormente registro, el sistema le envía un correo al nuevo usuario para que cambie su contraseña – Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero conserva su historial de actividad. – No se permite eliminar físicamente usuarios que tengan turnos o registros asociados. Trazabilidad: RF-USR-03	
US-04 Restricción de acceso por rol	Must 2 pts Sprint 1
Como responsable del sistema, quiero que cada pantalla y cada operación verifique el rol del usuario autenticado, para impedir que alguien acceda a información o funciones que no le corresponden. Criterios de aceptación – Un intento de acceder a una URL de otro rol devuelve un error de autorización y no expone datos. – Un paciente no puede acceder bajo ninguna ruta al historial, los turnos ni los pagos de otro paciente. – La verificación se realiza del lado del servidor, no solo ocultando opciones en la interfaz. Trazabilidad: RF-USR-04, RNF-03	

US-05 Actualización de datos personales	Should 1 pts Sprint 1
Como paciente, quiero consultar y modificar mis datos personales y de contacto, para que la sala pueda comunicarse conmigo con información vigente. Criterios de aceptación – El paciente puede modificar teléfono, email y domicilio. – El número de documento y la fecha de nacimiento no son editables por el paciente; requieren intervención administrativa. – Al cambiar el email, las notificaciones posteriores se envían a la nueva dirección. – El sistema confirma el guardado con un mensaje explícito. Trazabilidad: RF-USR-05	

Agenda médica

US-06 Carga de disponibilidad mensual	Must 4 pts Sprint 1
Como médico, quiero cargar los días y las franjas horarias en que atenderé durante el próximo mes, para que el sistema pueda abrir mi agenda a los pacientes. Criterios de aceptación – El médico selecciona un mes y agrega franjas indicando día, hora de inicio y hora de fin. – El sistema no permite cargar franjas sobre fechas ya pasadas. – El médico puede modificar o eliminar una franja mientras la disponibilidad no esté confirmada. Trazabilidad: RF-AGE-01	

US-07 Validación de la regla de dos jornadas semanales	Must 2 pts Sprint 1
Como médico, quiero que el sistema verifique que cargué dos jornadas de atención por semana, para cumplir con la regla de la sala y evitar agendas incompletas. Criterios de aceptación – El sistema recorre cada semana del mes y verifica que existan exactamente dos jornadas con franjas cargadas. – Si alguna semana no cumple la regla, la confirmación se bloquea y se indica cuáles son. – La cantidad de jornadas semanales exigidas es un parámetro configurable por el administrador. – Las semanas parcialmente incluidas en el mes se evalúan según el criterio acordado con el cliente. Trazabilidad: RF-AGE-02, RN-02	

US-08 Generación automática de turnos	Must 5 pts Sprint 1
Como sistema, quiero dividir cada franja horaria confirmada en turnos individuales, para que los pacientes tengan horarios concretos para reservar. Criterios de aceptación – Al confirmarse la disponibilidad, el sistema genera un turno por cada intervalo de la duración configurada para la especialidad. – La duración de consulta por especialidad la define el administrador; el valor inicial es 30 minutos. – Un intervalo sobrante menor a la duración de consulta no genera turno. – Cada turno generado queda en estado disponible, asociado al médico, la fecha y la hora. – La generación es idempotente: reconfirmar la misma disponibilidad no duplica turnos. Trazabilidad: RF-AGE-03	

US-09 Prevención de turnos superpuestos**Must | 3 pts | Sprint 1**

Como **sistema**, quiero **impedir la generación de turnos solapados para un mismo profesional**, para evitar dobles asignaciones imposibles de atender.

Criterios de aceptación

- El sistema rechaza la carga de dos franjas que se superponen para el mismo médico y día.
- El mensaje de error indica cuáles son las franjas en conflicto.
- La validación se aplica tanto en la carga inicial como en la modificación de disponibilidad.

Trazabilidad: RF-AGE-07, RNF-05

US-10 Apertura automática de la agenda**Must | 2 pts | Sprint 1**

Como **paciente**, quiero **ver publicada la agenda de un profesional apenas queda confirmada su disponibilidad**, para poder planificar mi consulta sin llamar por teléfono.

Criterios de aceptación

- Al confirmar la disponibilidad, los turnos generados quedan visibles para los pacientes sin intervención manual.
- Antes de la confirmación, ningún turno de ese mes es visible.
- La agenda muestra únicamente los turnos futuros y disponibles.
- El paciente ve especialidad, profesional, fecha y hora de cada turno.

Trazabilidad: RF-AGE-04

US-11 Vista de agenda del profesional**Must | 4 pts | Sprint 1**

Como **médico**, quiero **consultar mi agenda en vista diaria, semanal y mensual**, para organizar mi trabajo y saber a quién voy a atender.

Criterios de aceptación

- Las tres vistas muestran los turnos con su estado: disponible, reservado, cumplido, ausente o cancelado.
- En los turnos reservados se muestra el nombre del paciente y el motivo si fue indicado.
- El médico puede navegar entre períodos sin recargar toda la pantalla.
- La vista diaria ordena los turnos cronológicamente e identifica los huecos libres.

Trazabilidad: RF-AGE-05

6. Sprint 2 – Turnos y vacunas

Demo 22/10, entrega 25/10. El ciclo completo de reserva de turnos con sus notificaciones, y el módulo de vacunas, que puede avanzar en paralelo porque casi no comparte código con el resto.

20 User Stories – 39 puntos de historia

Reserva de turnos

US-12 Búsqueda de turnos disponibles	Must 3 pts Sprint 2
Como paciente, quiero buscar turnos filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas, para encontrar rápidamente un horario que me sirva. Criterios de aceptación – El paciente puede filtrar por especialidad, por profesional o por ambos. – El rango de fechas por defecto son los próximos treinta días. – Los resultados se agrupan por día y se ordenan cronológicamente. – Si no hay turnos que cumplan el filtro, se informa con un mensaje claro y se sugiere ampliar el rango. – La búsqueda responde en menos de tres segundos en condiciones normales de uso. Trazabilidad: RF-TUR-01, RNF-07	
US-13 Reserva de turno	Must 3 pts Sprint 2
Como paciente, quiero seleccionar un turno disponible y confirmarlo, para asegurarme la atención en el horario elegido. Criterios de aceptación – El paciente ve un resumen con profesional, especialidad, fecha y hora antes de confirmar. – Al confirmar, el turno pasa a estado reservado y deja de aparecer en las búsquedas. – El turno reservado queda visible en la sección de turnos del paciente. – El paciente puede indicar opcionalmente un motivo de consulta. – No se puede reservar un turno cuyo horario ya pasó. Trazabilidad: RF-TUR-02	
US-14 Confirmación de reserva por email	Must 2 pts Sprint 2
Como paciente, quiero recibir un email al confirmar mi turno, para tener constancia de la reserva fuera del sistema. Criterios de aceptación – El email se envía dentro del minuto posterior a la confirmación. – Incluye profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala. – Incluye instrucciones para cancelar el turno. – Si el envío falla, la reserva se mantiene válida y el fallo queda registrado para reintento. Trazabilidad: RF-TUR-03, RF-NOT-01	
US-15 Recordatorio automático de turno	Must 2 pts Sprint 2
Como paciente, quiero recibir un recordatorio por email antes de mi turno, para no olvidarme de asistir. Criterios de aceptación – El sistema envía el recordatorio con la antelación configurada por el administrador; el valor inicial son 24 horas. – No se envía recordatorio de turnos cancelados. – Se envía un único recordatorio por turno, sin duplicados ante reintentos del proceso. – El proceso corre de forma automática y deja registro de cada envío. Trazabilidad: RF-TUR-04, RF-NOT-01	

US-16 Cancelación de turno por el paciente	Must 2 pts Sprint 2
Como paciente, quiero cancelar un turno que reservé, para liberar el horario si no voy a poder asistir. Criterios de aceptación – El paciente puede cancelar desde su listado de turnos, con confirmación previa. – El turno cancelado vuelve al estado disponible y reaparece en las búsquedas. – La cancelación se permite hasta la antelación mínima configurada; el valor inicial son 24 horas. – El paciente y la sala reciben un email de aviso de la cancelación. – El turno cancelado queda registrado en el historial, no se elimina. Trazabilidad: RF-TUR-05, RN-06	
US-17 Gestión de turnos desde mostrador	Should 3 pts Sprint 2
Como personal administrativo, quiero reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente, para atender a quienes se comunican por teléfono o vienen presencialmente. Criterios de aceptación – El administrativo busca al paciente por documento, apellido o email. – Puede registrar un paciente nuevo desde el mismo flujo si no está en el sistema. – Al reprogramar, el turno original se libera y el nuevo queda reservado en una sola operación. – El paciente recibe el email correspondiente a la acción realizada. – Toda operación queda registrada indicando qué usuario la realizó. Trazabilidad: RF-TUR-06	
US-18 Registro del estado del turno	Must 2 pts Sprint 2
Como médico o administrativo, quiero marcar si el paciente asistió, no asistió o fue atendido, para que los reportes de asistencia reflejen lo que realmente ocurrió. Criterios de aceptación – Los estados posibles son reservado, cumplido, ausente y cancelado. – El estado solo puede modificarse el día del turno o posteriormente. – Un turno cumplido habilita la carga del historial clínico y el registro del pago. – El sistema deja constancia de quién cambió el estado y cuándo. Trazabilidad: RF-TUR-07	
US-19 Prevención de turnos duplicados	Should 1 pts Sprint 2
Como sistema, quiero impedir que un paciente reserve más de un turno con el mismo profesional en la misma fecha, para evitar reservas por error y el bloqueo innecesario de horarios. Criterios de aceptación – Al intentar la segunda reserva, el sistema informa el turno ya existente y ofrece reprogramarlo. – La restricción no aplica a turnos con profesionales de distinta especialidad. – Un turno cancelado previamente no cuenta para esta validación. Trazabilidad: RF-TUR-08	
US-20 Control de concurrencia en la reserva	Must 2 pts Sprint 2
Como sistema, quiero garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno simultáneamente, para evitar sobreventa de horarios y conflictos en el mostrador. Criterios de aceptación – La reserva se resuelve de forma atómica sobre el registro del turno. – El segundo paciente recibe un mensaje indicando que el turno ya no está disponible y vuelve a los resultados de búsqueda actualizados. – Existe una prueba que simula dos reservas concurrentes sobre el mismo turno y verifica que solo una prospere. – En ningún caso el sistema queda con dos reservas activas para el mismo turno. Trazabilidad: RF-TUR-09, RNF-05	

Notificaciones

US-21	Servicio de envío de notificaciones por email	Must 3 pts Sprint 2
Como responsable del sistema, quiero contar con un servicio único de envío de correo con plantillas y reintentos, para que todas las notificaciones del sistema sean consistentes y auditables. Criterios de aceptación – Existe un único componente responsable del envío, usado por todos los módulos. – Las plantillas de cada tipo de notificación están parametrizadas y son editables sin tocar el código de negocio. – Los envíos fallidos se reintentan una cantidad acotada de veces antes de marcarse como fallidos. Trazabilidad: RF-NOT-01		
US-22	Aviso por modificación de agenda	Must 1 pts Sprint 2
Como paciente, quiero ser avisado si el profesional cancela o modifica la franja de mi turno, para poder reprogramar a tiempo. Criterios de aceptación – Al bloquearse una franja con turnos reservados, todos los pacientes afectados reciben un email. – El email indica el turno afectado y cómo reprogramarlo. – Los turnos afectados pasan a estado cancelado con el motivo registrado. – El personal administrativo obtiene un listado de los pacientes a contactar. Trazabilidad: RF-NOT-02, RF-AGE-06		
US-23	Alerta de stock bajo a enfermería	Must 1 pts Sprint 2
Como enfermera, quiero recibir un aviso cuando el stock de una vacuna cae por debajo del umbral, para reponer antes de quedarme sin dosis. Criterios de aceptación – La alerta se genera automáticamente al cruzar el umbral, sin necesidad de consultar el módulo. – Las dos enfermeras reciben la notificación por email y la ven en el panel del módulo de vacunas. – No se repite la alerta de la misma vacuna hasta que el stock se repone por encima del umbral. – La alerta indica vacuna, stock actual y umbral configurado. Trazabilidad: RF-NOT-03, RF-VAC-04		

Gestión de vacunas

US-24	Catálogo de vacunas	Must 2 pts Sprint 2
Como enfermera, quiero administrar el listado de vacunas que aplica la sala, para trabajar sobre datos normalizados y no sobre texto libre. Criterios de aceptación – Se pueden crear, modificar y desactivar vacunas indicando denominación, laboratorio y esquema de dosis. – Una vacuna desactivada no puede recibir stock nuevo ni asignarse a turnos. – No se permiten dos vacunas activas con la misma denominación y laboratorio. – El catálogo es la única fuente de datos para el resto del módulo. Trazabilidad: RF-VAC-01		

US-25 Registro de stock por lote	Must 2 pts Sprint 2
Como enfermera, quiero registrar el ingreso de dosis indicando lote, cantidad y vencimiento, para saber con precisión de qué dispongo y hasta cuándo. Criterios de aceptación – El ingreso exige vacuna, número de lote, cantidad y fecha de vencimiento. – El sistema rechaza el ingreso de lotes con fecha de vencimiento pasada. – El stock total de una vacuna es la suma de sus lotes vigentes. – La pantalla de stock muestra el detalle por lote ordenado por vencimiento. Trazabilidad: RF-VAC-02	
US-26 Descuento automático de stock	Must 1 pts Sprint 2
Como sistema, quiero descontar la dosis del lote correspondiente al registrarse una aplicación, para mantener el stock actualizado sin conteos manuales. Criterios de aceptación – El descuento se aplica sobre el lote seleccionado en el registro de aplicación. – Si no se selecciona lote, el sistema propone el de vencimiento más próximo entre los vigentes. – El stock de un lote nunca puede quedar negativo. – Si el registro de aplicación se anula, el stock se restituye y queda constancia. Trazabilidad: RF-VAC-03, RNF-05	
US-27 Umbral mínimo por vacuna	Must 2 pts Sprint 2
Como enfermera, quiero definir la cantidad mínima de dosis a partir de la cual quiero ser alertada, para ajustar el aviso al consumo real de cada vacuna. Criterios de aceptación – El umbral se configura por vacuna y admite valores distintos para cada una. – El sistema propone un umbral por defecto para las vacunas nuevas. – Al modificar el umbral, se reevalúa de inmediato si corresponde generar una alerta. – El panel del módulo destaca visualmente las vacunas por debajo del umbral. Trazabilidad: RF-VAC-04	
US-28 Turno de vacunación con verificación de stock	Must 2 pts Sprint 2
Como enfermera, quiero otorgar un turno de vacunación solo si hay dosis disponibles, para no comprometer una aplicación que después no voy a poder realizar. Criterios de aceptación – Al asignar el turno se selecciona la vacuna y el sistema verifica que exista stock vigente. – Si no hay stock, la asignación se bloquea con un mensaje que indica la cantidad disponible. – El sistema considera comprometidas las dosis de los turnos de vacunación ya otorgados. – El paciente recibe la confirmación del turno por email. – El turno de vacunación se gestiona en la agenda propia del vacunatorio. Trazabilidad: RF-VAC-05, RN-05	
US-29 Registro de aplicación de dosis	Must 1 pts Sprint 2
Como enfermera, quiero registrar cada dosis aplicada con todos sus datos, para dejar trazabilidad sanitaria de qué se aplicó, a quién y de qué lote. Criterios de aceptación – El registro guarda paciente, vacuna, lote, fecha, hora y enfermera responsable. – La enfermera responsable se toma del usuario autenticado, no se ingresa manualmente. – El registro no puede eliminarse; una corrección se hace por anulación con motivo. – La aplicación registrada queda vinculada al turno de vacunación si existió. Trazabilidad: RF-VAC-06, RNF-04	

Agenda médica

US-30 Bloqueo de franjas publicadas

Should | 3 pts | Sprint 2

Como **médico**, quiero **bloquear una franja ya publicada por ausencia o licencia**, para evitar que los pacientes reserven horarios que no voy a poder atender.

Criterios de aceptación

- El médico selecciona un rango de fechas u horas y confirma el bloqueo indicando el motivo.
- El personal administrativo también podrá bloquear franjas a pedido de los médicos.
- Los turnos disponibles del rango dejan de ofrecerse.
- Los turnos ya reservados se cancelan y disparan el aviso a los pacientes afectados.
- El sistema advierte la cantidad de turnos reservados que se verán afectados antes de confirmar.
- El bloqueo puede revertirse mientras no hayan pasado las fechas involucradas.

Trazabilidad: RF-AGE-06

Usuarios y acceso

US-31 Recuperación de contraseña

Should | 1 pts | Sprint 2

Como **usuario registrado**, quiero **recuperar el acceso si olvido mi contraseña**, para no depender del personal de la sala para volver a entrar.

Criterios de aceptación

- El usuario solicita la recuperación indicando su email.
- El sistema envía un enlace de un solo uso con vencimiento acotado.
- La respuesta en pantalla es la misma exista o no la cuenta, para no revelar usuarios registrados.
- Al definirse la nueva contraseña, el enlace queda invalidado.

Trazabilidad: RF-USR-06, RNF-01

7. Sprint 3 – Pagos, historial clínico, reportes y móvil

Demo 12/11, entrega 15/11. Todo lo que se apoya sobre el turno ya existente, más la aplicación móvil para pacientes.

27 User Stories – 46 puntos de historia

Pagos y coberturas

US-32 Registro de cobertura médica	Must 2 pts Sprint 3
Como paciente, quiero registrar mi obra social o prepaga con su plan y número de afiliado, para que se aplique la cobertura correspondiente al abonar la consulta. Criterios de aceptación – El paciente selecciona la entidad de un listado administrado por el administrador. – Se registran plan y número de afiliado. – Un paciente puede no tener cobertura, en cuyo caso se lo considera particular. – El dato es declarativo: el sistema no valida contra el padrón de la entidad. – El personal administrativo también puede cargar o corregir la cobertura. Trazabilidad: RF-PAG-01	
US-33 Configuración de aranceles	Must 2 pts Sprint 3
Como administrador, quiero definir el arancel de cada especialidad y tipo de prestación, para que el sistema calcule solo el importe de cada consulta. Criterios de aceptación – Se define un arancel por especialidad, con vigencia desde una fecha determinada. – Se puede definir un valor de coseguro por entidad de cobertura. – Al modificarse un arancel, los pagos ya registrados conservan el valor vigente al momento del cobro. – El sistema conserva el historial de aranceles con sus fechas de vigencia. Trazabilidad: RF-PAG-02	
US-34 Cálculo del importe según cobertura	Must 3 pts Sprint 3
Como sistema, quiero calcular el importe a abonar según la cobertura registrada del paciente, para cobrar el valor correcto sin cálculos manuales en el mostrador. Criterios de aceptación – Un paciente sin cobertura abona el arancel completo de la especialidad. – Un paciente con cobertura abona el coseguro definido para su entidad. – El cálculo usa el arancel vigente a la fecha de la consulta. – La pantalla muestra el desglose: arancel, cobertura aplicada e importe final. – Si la entidad no tiene coseguro configurado, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro. Trazabilidad: RF-PAG-03	
US-35 Registro del pago de la consulta	Must 2 pts Sprint 3
Como personal administrativo, quiero registrar el pago de una consulta indicando el medio utilizado, para dejar asentado el cobro y poder emitir el comprobante. Criterios de aceptación – El pago se asocia a un turno en estado cumplido. – Los medios de pago disponibles los configura el administrador. – Un turno no puede tener dos pagos activos simultáneos. – El sistema registra fecha, hora, importe, medio de pago y usuario que lo registró. – El sistema solo registra el pago; no procesa la transacción en línea. Trazabilidad: RF-PAG-04	

US-36 Comprobante de pago	Must 1 pts Sprint 3
Como paciente, quiero obtener un comprobante por cada pago que realizo, para tener constancia de lo abonado. Criterios de aceptación – El comprobante se genera automáticamente al registrarse el pago. – Incluye numeración correlativa, datos del paciente, prestación, importe y medio de pago. – El comprobante queda disponible en la cuenta del paciente y puede reimprimirse. – La numeración no presenta huecos ni duplicados. Trazabilidad: RF-PAG-05	
US-37 Factura descargable en PDF	Must 2 pts Sprint 3
Como paciente, quiero descargar la factura de mis consultas en formato PDF, para presentarla ante mi cobertura o conservarla. Criterios de aceptación – La factura se genera en PDF a partir de los datos del pago registrado. – Contiene datos de la sala, del paciente, detalle de la prestación e importe. – El documento es un comprobante interno, sin homologación fiscal, según el supuesto acordado. – La descarga solo está disponible para el paciente titular y para el personal administrativo. Trazabilidad: RF-PAG-06	
US-38 Historial de pagos del paciente	Should 1 pts Sprint 3
Como paciente, quiero consultar el listado de mis pagos y comprobantes, para revisar lo abonado sin tener que pedirlo en el mostrador. Criterios de aceptación – El listado muestra fecha, prestación, profesional, importe y medio de pago. – Puede filtrarse por rango de fechas. – Desde cada fila se accede al comprobante y a la factura. – El paciente solo ve sus propios pagos. Trazabilidad: RF-PAG-07, RNF-03	

Historial clínico

US-39 Carga de diagnóstico y tratamiento	Must 3 pts Sprint 3
Como médico, quiero registrar el diagnóstico y el tratamiento de la consulta en la ficha del paciente, para dejar asentada la evolución clínica. Criterios de aceptación – La carga se realiza sobre un turno en estado cumplido. – Se registran diagnóstico, tratamiento indicado y observaciones. – La entrada queda firmada con el profesional, la fecha y la hora, tomados del usuario autenticado. – Solo un usuario con rol Médico puede realizar la carga. – La entrada guardada no puede editarse ni borrarse; se corrige mediante una entrada nueva. Trazabilidad: RF-HIS-01, RN-07	

US-40 Consulta de la ficha del paciente	Must 2 pts Sprint 3
Como médico, quiero ver la ficha completa del paciente con las entradas de todos los profesionales de la sala, para atender con el contexto clínico completo. Criterios de aceptación – Las entradas se muestran en orden cronológico inverso, identificando autor y especialidad. – La ficha muestra también las vacunas aplicadas en la sala. – El médico puede filtrar por especialidad o por rango de fechas. – El acceso a la ficha queda registrado en el log de auditoría. Trazabilidad: RF-HIS-02	
US-41 Historial clínico del paciente	Must 2 pts Sprint 3
Como paciente, quiero consultar mi historial médico desde la plataforma, para tener acceso a mis diagnósticos y tratamientos sin pedir una copia. Criterios de aceptación – El paciente accede en modo de solo lectura, sin posibilidad de modificar ni eliminar. – Ve el mismo texto cargado por el profesional, sin notas internas. – Solo accede a su propia ficha; cualquier intento de acceder a otra es rechazado y registrado. – El historial puede descargarse en PDF. Trazabilidad: RF-HIS-03, RNF-03	
US-42 Trazabilidad de las entradas clínicas	Should 2 pts Sprint 3
Como responsable del sistema, quiero que ninguna entrada del historial pueda eliminarse y que toda corrección quede trazada, para preservar la integridad de la información clínica. Criterios de aceptación – No existe ninguna función de eliminación de entradas del historial en ninguna interfaz. – Una corrección se registra como entrada nueva vinculada a la original. – La ficha muestra las correcciones junto a la entrada corregida, sin ocultar la versión previa. – Cada entrada conserva autor, fecha y hora de creación. Trazabilidad: RF-HIS-04, RNF-02	
US-43 Antecedentes, alergias y medicación habitual	Should 1 pts Sprint 3
Como médico, quiero consultar y actualizar los antecedentes, alergias y medicación habitual del paciente, para evitar indicaciones que puedan ser riesgosas. Criterios de aceptación – La ficha tiene una sección destacada con alergias, visible en todas las vistas clínicas. – Se registran antecedentes personales y medicación habitual. – El paciente puede consultar esta sección pero no modificarla. – Cada modificación queda registrada con autor y fecha. Trazabilidad: RF-HIS-05	
US-44 Auditoría de accesos al historial	Should 1 pts Sprint 3
Como responsable del sistema, quiero registrar cada acceso al historial clínico de un paciente, para poder investigar accesos indebidos a información sensible. Criterios de aceptación – Se registra usuario, paciente consultado, fecha, hora y tipo de acceso. – El registro incluye tanto los accesos exitosos como los intentos rechazados. – El log es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador. – El administrador puede filtrar el log por usuario, paciente y rango de fechas. Trazabilidad: RF-HIS-06, RNF-04	

Reportes

US-45	Reporte de turnos por especialidad	Must 2 pts Sprint 3
Como administrador, quiero obtener la cantidad de turnos por especialidad y período, para evaluar la demanda de cada profesional y ajustar la disponibilidad. Criterios de aceptación – El reporte muestra turnos totales, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad. – Puede desglosarse por profesional. – Admite un rango de fechas definido por el usuario. – Incluye una representación gráfica de la distribución. Trazabilidad: RF-REP-01		
US-46	Reporte de stock de vacunas	Must 2 pts Sprint 3
Como administrador, quiero consultar existencias, consumo y vencimientos de vacunas, para planificar la reposición y evitar pérdidas por vencimiento. Criterios de aceptación – El reporte muestra stock actual por vacuna y por lote. – Informa el consumo del período seleccionado. – Destaca los lotes vencidos y los próximos a vencer. – Señala las vacunas por debajo del umbral mínimo. Trazabilidad: RF-REP-02		
US-47	Reporte de pagos realizados	Must 1 pts Sprint 3
Como administrador, quiero obtener el detalle de los pagos por período, medio de pago y cobertura, para controlar la recaudación de la sala. Criterios de aceptación – El reporte totaliza importes por período, medio de pago y entidad de cobertura. – Distingue consultas particulares de consultas con cobertura. – Los pagos anulados se muestran identificados y no suman al total. – Admite desglose por especialidad. Trazabilidad: RF-REP-03		
US-48	Reporte de asistencia de pacientes	Must 1 pts Sprint 3
Como administrador, quiero conocer el nivel de ausentismo a los turnos, para tomar medidas sobre los turnos que se pierden. Criterios de aceptación – El reporte calcula el porcentaje de ausentismo sobre los turnos reservados del período. – Puede desglosarse por profesional, especialidad y día de la semana. – Identifica a los pacientes con mayor cantidad de ausencias. – Excluye del cálculo los turnos cancelados por la sala. Trazabilidad: RF-REP-04		
US-49	Filtros comunes de reportes	Should 1 pts Sprint 3
Como administrador, quiero aplicar los mismos filtros en todos los reportes, para no tener que aprender una lógica distinta en cada pantalla. Criterios de aceptación – Todos los reportes admiten rango de fechas, profesional y especialidad. – Los filtros no aplicables a un reporte determinado se ocultan. – El rango de fechas por defecto es el mes en curso. – El reporte indica en su encabezado los filtros aplicados. Trazabilidad: RF-REP-05		

US-50 Exportación de reportes	Should 1 pts Sprint 3
Como administrador , quiero exportar cualquier reporte a PDF o CSV , para compartirlo o analizarlo fuera del sistema.	
Criterios de aceptación	
– El archivo exportado respeta los filtros aplicados en pantalla. – El PDF incluye encabezado con nombre del reporte, filtros y fecha de generación. – El CSV incluye la fila de encabezados de columna. – La exportación está disponible únicamente para el rol Administrador.	
Trazabilidad: RF-REP-06	

Aplicación móvil

US-51 Acceso desde la aplicación móvil	Must 2 pts Sprint 3
Como paciente , quiero ingresar a la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web , para no tener que gestionar dos cuentas distintas.	
Criterios de aceptación	
– Las credenciales son las mismas que en la web; no existe un registro separado. – La sesión en el móvil es independiente de la sesión web. – La aplicación solo está disponible para el rol Paciente. – El diseño mantiene la identidad visual del sistema web.	
Trazabilidad: RF-MOV-01, RNF-06	

US-52 Gestión de turnos desde el móvil	Must 3 pts Sprint 3
Como paciente , quiero buscar, reservar y cancelar turnos desde mi teléfono , para resolver el turno en el momento en que me acuerdo, sin abrir la computadora.	
Criterios de aceptación	
– El flujo de búsqueda, reserva y cancelación replica las reglas de la versión web. – La pantalla está adaptada a dispositivos móviles. – Los turnos reservados desde el móvil son los mismos que se ven en la web. – Las validaciones de concurrencia y duplicados se aplican por igual.	
Trazabilidad: RF-MOV-02	

US-53 Historial clínico desde el móvil	Must 2 pts Sprint 3
Como paciente , quiero consultar mi historial médico desde la aplicación , para tenerlo a mano cuando lo necesito.	
Criterios de aceptación	
– Se muestra la misma información que en la web, en modo de solo lectura. – El acceso exige sesión activa y se registra en el log de auditoría. – La información no se almacena en el dispositivo tras cerrar sesión.	
Trazabilidad: RF-MOV-03, RNF-02	

US-54 Recordatorios en el móvil	Must 1 pts Sprint 3
Como paciente , quiero recibir los recordatorios de turno en la aplicación , para enterarme sin depender de revisar el correo.	
Criterios de aceptación	
– Los recordatorios se muestran en una sección de avisos dentro de la aplicación. – El envío por email se mantiene en paralelo. – La notificación emergente queda fuera del alcance de esta versión, según el supuesto acordado.	
Trazabilidad: RF-MOV-04	

US-55 Pagos y comprobantes desde el móvil**Should | 2 pts | Sprint 3**

Como **paciente**, quiero **consultar mis pagos y descargar comprobantes desde la aplicación**, para no tener que pasar por el mostrador para pedirlos.

Criterios de aceptación

- El listado de pagos replica el de la versión web.
- El comprobante y la factura pueden descargarse o compartirse desde el dispositivo.
- El registro del pago se sigue realizando en el mostrador; la aplicación solo consulta.

Trazabilidad: RF-MOV-05

Gestión de vacunas

US-56 Vencimiento y baja de lotes**Should | 2 pts | Sprint 3**

Como **enfermera**, quiero **ser alertada de los lotes próximos a vencer y poder dar de baja stock**, para no aplicar dosis vencidas y mantener el stock fiel a la realidad.

Criterios de aceptación

- El sistema alerta sobre los lotes que vencen dentro del plazo configurado.
- Los lotes vencidos dejan de contar como stock disponible automáticamente.
- La baja por rotura o vencimiento exige indicar cantidad y motivo.
- Toda baja queda registrada con enfermera responsable, fecha y motivo.

Trazabilidad: RF-VAC-07, RNF-04

US-57 Carnet de vacunación del paciente**Should | 1 pts | Sprint 3**

Como **paciente**, quiero **consultar las vacunas que me aplicaron en la sala**, para conocer mi esquema sin tener que preguntarlo.

Criterios de aceptación

- El listado muestra vacuna, fecha de aplicación y dosis del esquema.
- Se indica si el esquema quedó incompleto según las dosis definidas para esa vacuna.
- El listado puede descargarse en PDF.
- Solo incluye aplicaciones registradas en la sala.

Trazabilidad: RF-VAC-08

Notificaciones

US-58 Registro de notificaciones enviadas**Should | 1 pts | Sprint 3**

Como **administrador**, quiero **consultar el registro de las notificaciones que envió el sistema**, para diagnosticar reclamos por avisos que el paciente dice no haber recibido.

Criterios de aceptación

- El log guarda destinatario, tipo de notificación, fecha, hora y estado de envío.
- Los envíos fallidos quedan identificados con el motivo del fallo.
- El log puede filtrarse por paciente, tipo y rango de fechas.
- Solo es accesible para el rol Administrador.

Trazabilidad: RF-NOT-04

8. Backlog no comprometido

Candidatas a reducción de alcance. User Stories de prioridad Could, no asignadas a ningún sprint. Se incorporan solo si la velocidad real supera lo planificado, y son las primeras en descartarse si ocurre lo contrario.

4 User Stories – 10 puntos de historia

Reserva de turnos

US-59	Lista de espera de turnos	Could 3 pts
Como paciente , quiero anotarme en una lista de espera cuando no hay turnos disponibles , para aprovechar los horarios que se liberan por cancelaciones.		
Criterios de aceptación		
– El paciente se anota indicando especialidad, profesional y rango de fechas de interés. – Al liberarse un turno que cumple el criterio, se notifica a los anotados en orden de inscripción. – La notificación otorga un plazo acotado de prioridad antes de liberar el turno al público general. – El paciente puede darse de baja de la lista en cualquier momento.		
Trazabilidad: RF-TUR-10		

Agenda médica

US-60	Calendario de feriados	Could 2 pts
Como administrador , quiero cargar los feriados y días no laborables de la sala , para que no se generen turnos en fechas en que no se atiende.		
Criterios de aceptación		
– El administrador carga fechas puntuales o rangos con una descripción. – La generación automática de turnos excluye esas fechas. – Si se agrega un feriado sobre fechas con turnos ya reservados, el sistema advierte antes de aplicarlo. – El calendario puede consultarse por año.		
Trazabilidad: RF-AGE-08		

Pagos y coberturas

US-61	Anulación de pagos	Could 2 pts
Como personal administrativo , quiero anular un pago registrado por error , para corregir el cobro sin alterar la trazabilidad contable.		
Criterios de aceptación		
– La anulación exige indicar un motivo. – El pago original no se elimina; queda marcado como anulado. – Los reportes descuentan el importe anulado del total del período. – Se registra quién realizó la anulación y cuándo.		
Trazabilidad: RF-PAG-08, RNF-04		

Historial clínico

US-62 Adjuntar estudios a la ficha**Could | 3 pts**

Como **médico**, quiero **adjuntar estudios y archivos a la ficha del paciente**, para centralizar la información clínica en un solo lugar.

Criterios de aceptación

- Se admiten formatos de imagen y PDF con un tamaño máximo configurable.
- Cada adjunto queda vinculado a una entrada del historial.
- El paciente puede descargar sus propios adjuntos.
- El acceso a los adjuntos se registra en el log de auditoría.

Trazabilidad: RF-HIS-07

9. Pantallas referenciadas (insumo para wireframes y sitemap)

Listado de las vistas que surgen de las User Stories anteriores. Cada una necesita su wireframe antes de que la historia correspondiente entre a un sprint.

Rol	Pantallas	Sprint
Público	Registro de paciente, inicio de sesión, recuperación de contraseña.	1 y 2
Paciente (web)	Panel de inicio, búsqueda de turnos, detalle y confirmación de reserva, mis turnos, mis datos, mi historial clínico, mis pagos y comprobantes, mi carnet de vacunación.	1 a 3
Médico	Carga de disponibilidad mensual, agenda diaria, semanal y mensual, bloqueo de franjas, ficha del paciente, carga de diagnóstico y tratamiento.	1 a 3
Enfermera	Panel de vacunas, catálogo, ingreso de stock por lote, configuración de umbrales, agenda del vacunatorio, registro de aplicación, bajas de lote.	2 y 3
Administrativo	Búsqueda de paciente, gestión de turnos por mostrador, control de asistencia, registro de pago, emisión de comprobante.	2 y 3
Administrador	Gestión de usuarios internos, parámetros del sistema, aranceles y coberturas, los cuatro reportes, log de auditoría, log de notificaciones.	1 a 3
Paciente (móvil)	Acceso, turnos, historial, avisos, pagos.	3

10. Resumen de esfuerzo

Etapas	User Stories	Puntos en US	Reserva para bugs	Demanda total	Capacidad estimada
Sprint 1	11	32	0	32	30
Sprint 2	20	39	3	42	30
Sprint 3	27	46	5	51	45
Backlog	4	10	—	—	—
Total comprometido	58	117	8	125	105

Hallazgo: la demanda supera la capacidad

Con la hipótesis de capacidad del bosquejo de sprints — diez integrantes, tope de diez horas semanales, factor de foco del 60% y equivalencia de cuatro horas por punto — la capacidad acumulada de los tres sprints es de 105 puntos, mientras que la demanda comprometida asciende a 125. El déficit es de 20 puntos, alrededor del 19% del alcance.

Esto no invalida el plan: es el resultado que hay que llevar a la reunión de priorización del Sprint 0. Las alternativas, en orden de preferencia:

- **Recalibrar la equivalencia.** El valor de cuatro horas por punto es una hipótesis sin evidencia. Al cierre del Sprint 1 se conoce la velocidad real y el déficit puede desaparecer o agravarse. Ninguna decisión de alcance debería tomarse antes de ese dato.
- **Negociar el alcance con el cliente.** Aplicar el plan de reducción del bosquejo de sprints: reducir la aplicación móvil a una aplicación web progresiva sobre el front-end existente y postergar las historias de prioridad Should con menor valor demostrable.
- **Adelantar trabajo.** Si el Sprint 1 cierra con capacidad sobrante, tomar historias del Sprint 2, que es el que arranca con menos holgura.

Documentar este análisis y su evolución a lo largo de los sprints alimenta directamente dos de las métricas definidas en el Start up: el desvío de estimación y la cantidad de re-priorizaciones por sprint.

11. Distribución por prioridad y módulo

Módulo	Must	Should	Could	US	Puntos
Usuarios y acceso	4	2	0	6	13
Agenda médica	6	1	1	8	25
Reserva de turnos	7	2	1	10	23
Notificaciones	3	1	0	4	6
Gestión de vacunas	6	2	0	8	13
Pagos y coberturas	6	1	1	8	15
Historial clínico	3	3	1	7	14
Reportes	4	2	0	6	8
Aplicación móvil	4	1	0	5	10
Total	43	15	4	62	127

Las estimaciones del Sprint 1 fueron realizadas sin asistencia de herramientas de inteligencia artificial, según lo solicitan las pautas del proyecto. El tiempo real de cada User Story debe registrarse durante el sprint para poder comparar contra lo estimado y alimentar la estimación asistida de los Sprints 2 y 3, dejando documentados la herramienta, su versión y el prompt utilizado.